

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°141/MVE-BDBV/01/10/2026

Date du rapport : 02 octobre 2026

Date de publication : 03 octobre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Un total de 66 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 22 décès communautaires ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces au Nord-Kivu (33 cas), en Ituri (28 cas), au Haut-Uélé (3 cas) et à la Tshopo (2 cas). De plus, 16 décès ont été enregistrés dans les CTE ; **Nouvelle zone de santé touchée : Alimbongo (Nord-Kivu), avec 4 cas confirmés dont 2 décès**
- 323 nouveaux échantillons a été analysé ; 66 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 20,4 % de positivité.

CUMUL DES
CAS
8 442

CUMUL DES
DÉCÈS
CONFIRMÉS
4 080

LETALITE
48,3 %

PATIENTS EN
ISOLEMENT/CTE
846

CUMUL DES
GUÉRIS
2 213

TAUX DE SUIVI DES
CONTACTS
(Du Jour)
73,1 %



Provinces touchées et zones de santé touchées



7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi



64 Zones de santé touchées sur 167 (38,3%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Pour la journée du **02 octobre**, **66 nouveaux cas confirmés** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont **22 décès communautaires** ont été notifiés dans 4 provinces : le Nord-Kivu (33 cas), l'Ituri (28 cas), le Haut-Uélé (3 cas) et la Tshopo (2 cas).

De plus, **16 décès ont été enregistrés dans les CTE** (10 en Ituri, 5 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé), ce qui porte à 38 le nombre total des décès confirmés pour la période considérée.

Cependant, 31 patients (14 au Nord-Kivu, 9 en Ituri et 8 au Haut-Uélé) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE.

Au **02 octobre 2026**, la RDC cumule **8 442 cas confirmés** et **4 080 décès** (létalité : **48,3 %**). L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec **75,5 %** des cas confirmés cumulés rapportés et **42,4 %** des nouveaux cas confirmés. En revanche, la province du Nord-Kivu présente une létalité supérieure à la moyenne nationale, soit **59,1%**.

Avec l'ajout de la zone de santé d'Alimbongo au Nord-Kivu, **64 zones de santé sur 167 (38,3 %)**, réparties dans **sept provinces**, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 02 octobre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	28	6370	2 933	46,0%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	33	1657	979	59,1%	17/34 (50,0 %)
Haut-Uélé	3	352	146	41,5%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	2	48	16	33,3%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	66	8 442	4 080	48,3%	64/167 (38,3 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 02 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6370	2933	46,0%	28	5	10	15
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	203	46	22,7%	1	0	0	0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1759	574	32,6%	5	0	2	2
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	82	31	37,8%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	37	12	32,4%				0
Komanda	173	106	61,3%	3	0	2	2
Lita	289	145	50,2%	1	0	0	0
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	34	9	26,5%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	32	12	37,5%				0
Mandima	156	79	50,6%	4	0	0	0
Mangala	362	156	43,1%				0
Mongbwalu	706	333	47,2%	1	0	0	0
Nia-Nia	309	173	56,0%	4	3	3	6

Nizi	784	281	35,8%	1		1	1
Nyankunde	130	37	28,5%	1	0	0	0
Rimba	12	4	33,3%				0
Rwampara	1104	376	34,1%	7	2	2	4
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	1657	979	59,1%	33	16	5	21
Beni	376	252	67,0%	9	5	4	9
Biena	19	7	36,8%				0
Butembo	272	174	64,0%	2	1	0	1
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	59	21	35,6%	2	2	0	2
Katwa	579	362	62,5%	8	3	0	3
Kayna	3	2	66,7%	2	2	0	2
Kyondo	34	20	58,8%	1			0
Lubero	22	11	50,0%	1			0
Mabalako	41	15	36,6%	3	1	0	1
Alimbongo	4	2	50,0%	4	2	0	2
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	31	11	35,5%	0	0	1	1
Musienene	127	68	53,5%	1	0	0	0
Mutwanga	15	3	20,0%				0
Oicha	29	16	55,2%				0
Vuhovi	32	10	31,3%				0
Haut-Uélé	352	146	41,5%	3	1	1	2
Boma Mangbetu	41	17	41,5%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	87	40	46,0%	0	0	1	1
Rungu	4	1	25,0%	1	0	0	0
Wamba	114	42	36,8%	2	1		1
Tshopo	48	16	33,3%	2	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	27	10	37,0%	2	0	0	0
Mangobo	6	3	50,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0

Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8442	4080	48,3%	66	22	16	38

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.
NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 02 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	23	2	25	21	2	2	0	23	10
Bas Uélé	153	3	156	18	2	135	1	20	0
Ituri	1 089	75	1164	129	75	959	0	204	111
Nord-Kivu	937	39	976	116	31	829	0	147	82
Sud Ubangi	57	0	57	1	0	56	0	1	1
Tshopo	111	4	115	5	5	105	0	10	3
Total Général	2 370	123	2 493	290	115	2 086	1	405	207

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

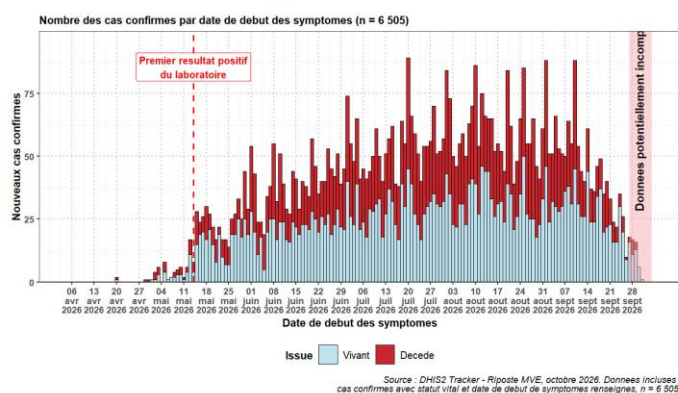
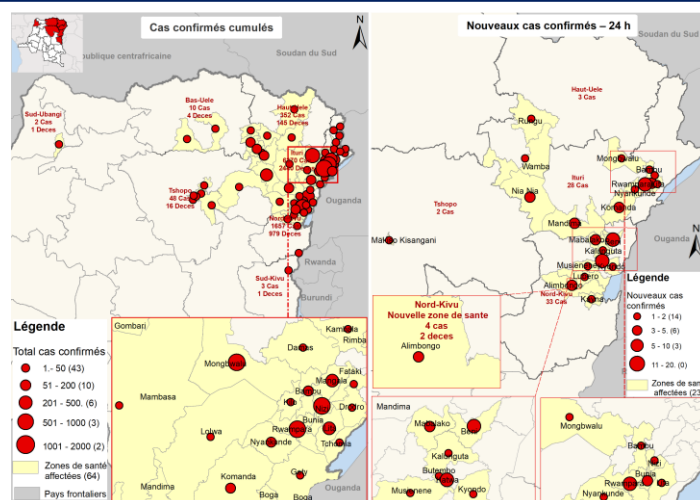


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Pour la journée du 02 octobre, **2 493 alertes** ont été remontées, **2 492** (99,9 %) ont été vérifiées dont **405** (16,3 %) validées comme cas suspects. Parmi ceux-ci, **405** (100%) ont été investigués. Ainsi, 207 cas suspects ont été transférés vers les CT/CTE ([Tableau 3](#)).

Parmi **32 654** contacts en cours de suivi, **23 876 contacts** ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de **73,1%**, est inférieure à celle de la veille (73,1%) mais demeurant inférieure au seuil requis (95,0 %). Cette proportion était de 94,6 % (175/185) au (Bas Uélé), 87,0% (1 631/1 874) au Haut Uélé, 86,0% (583/678) à la Tshopo, 82,9% (12 660/1 5275) en Ituri, 77,3 % (34/44) au Sud Ubangi, 60,2% (8 793/14 595) au Nord Kivu.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Huit (8) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC du Tableau 4, dont sept (7) en Ituri et une (1) au Nord-Kivu. En Ituri, les sept alertes ont été validées : deux suspects du PoC Mudzibala (ZS de Bunia) ont été transférés aux CTE Elikya et CME, celui du PoC DGRPI Nizi a été référé à l'HGR de Nizi et, aux PoC Mabakese et Mankoko 2 (ZS de Mambasa), trois suspects ont été transférés au CTE de Mambasa et le quatrième a refusé (taux de transfert de 85,7 %). Au Nord-Kivu, l'alerte du PoC Mukulia (ZS de Beni) a été invalidée. Au Bas-Uélé, hors Tableau 4, les sept (7) alertes des PoC Sukisa et Koteli ont été invalidées (total national : 15).

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 01 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	96,7% (58/60)	81,0% (17/21)	100,0% (18/18)	93,9% (93/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	147 336	98 712	22 441	268 489
% des voyageurs screenés	95,9%	98,2%	99,2%	97,0%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,5%	98,2%	98,7%	97,9%
% des voyageurs sensibilisés	99,5%	98,2%	100,0%	99,0%
Nombre d'alertes notifiées	7	1	0	8
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	7	0	0	7
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CTE/CT	85,7%	NA	NA	85,7%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	NA	NA	100,0%

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 28 nouveaux résultats positifs** (23 vivants et 5 décès) sur 171 échantillons reçus et analysés (**positivité : 16,4 %**).
- **Nord-Kivu : 33 nouveaux résultats positifs** (17 vivants et 16 décès) sur 116 échantillons reçus et analysés (**positivité : 28,4 %**).
- **Haut-Uélé : 3 nouveaux résultats positifs** (2 vivants et 1 décès) sur 20 échantillons reçus et analysés (**positivité : 15,0 %**).
- **Tshopo : 2 nouveau résultat positif reçus** (2 vivants) sur 9 échantillons reçus et analysés (**positivité : 22,2 %**).
- **Bas Uélé : 7 échantillons** (3 sangs et 4 swabs) reçus et analysés au laboratoire de Buta, **tous sont revenus négatifs**.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 21 rings ont été ouverts sur 39 (53,8 %), 70 ménages décontaminés sur 76 (92,1 %) et 12 FOSSA décontaminées sur 13 (92,3 %). Sur 69 alertes EDS (dont 8 reports), 49 EDS ont été réalisés (71,0 %) et 38 corps swabés.
- **Nord-Kivu** : 15 rings ont été ouverts sur 25 (60,0 %), 7 ménages décontaminés sur 30 (23,3 %) et 15 ESS décontaminées sur 20 (75,0 %) ; aucun ménage décontaminé n'a été doté en kit et 4 évaluations score card PCI réalisées à Butembo ont donné un score moyen de 42 %. Sur 51 alertes EDS, 51 EDS ont été réalisés (100 %) et 51 corps swabés.
- **Haut-Uélé** : 3 rings ont été ouverts sur 4 (75,0 %), 25 ménages décontaminés sur 29 (86,2 %) et 3 ESS décontaminées sur 3 (100 %) ; 15 ESS ont été supervisées, 64 prestataires briefés (100 %) et les HGR de Pawa, d'Isiro et de Wamba ont reçu des kits PCI. Sur 7 alertes EDS, 6 EDS ont été réalisés (85,7 %) et 6 corps swabés, avec un refus à Isiro (AS Tuluba).
- **Tshopo** : 18 ESS sur 18 ont été suivies dans 6 ZS et 186 prestataires briefés (100 %) ; la formation intégrée de 150 PPL des ESS privés de Makiso-Kisangani s'est achevée et une église, un centre de réflexologie (cas 45) et la clinique Kawaki (cas 44) ont été décontaminés. En cumul, 35 ESS sur 35 (100 %) et 26 ménages sur 31 (83,9 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures.
- **Bas-Uélé** : 10 ESS sur 10 (100 %) ont été suivies à Viadana, Buta et Ganga, 54 prestataires sur 54 (100 %) et 10 hygiénistes ont été briefés et 3 triages sur 3 (100 %) sont fonctionnels à Buta. Sur 3 alertes de décès (2 à Ganga et 1 à Buta), 2 corps ont été swabés à Ganga, sans EDS réalisé, et un échec a été enregistré dans l'AS Triangle (ZS de Buta).

2.4.2. Défis

En Ituri, En Ituri, l'ouverture des rings demeure insuffisante (53,8 % ; 21/39) en raison du manque d'équipes à Komanda, Mangala et Mandima et de la grève des équipes à Bunia ; 10 corps n'ont pas été swabés faute d'intrants et d'équipes à Mandima ou à la suite de refus des familles, des résistances persistent à Bambu, Rwampara, Mangala et Fataki, les équipes EDS manquent de moyens de transport à Kilo, Nia-Nia, Mandima, Damas et Fataki et aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. **Au Nord-Kivu**, la décontamination des ménages reste faible (23,3 % ; 7/30), aucun ménage n'est doté en kits et le score moyen PCI des ESS évaluées à Butembo n'atteint que 42 %. **Au Haut-Uélé**, seules 4 ZS sur 7 rapportent leurs activités, les ZS de Pawa et de Wamba n'ont pas de CTE normé, la population de l'AS Gbonzunzu (Pawa) reste hostile et seules 2 ESS sur 15 atteignent 80 % au score PCI).

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 74 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 90 sorties, dont 9 guérisons. Au total, 378 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée. Le taux d'occupation des lits était de **37,2%** ; 336 patients sur 359 (93,6 %) ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (13/13), à la crèche (5/5) et dans la communauté (50/50) ; 31 malades sont en état critique.
- **Au Nord-Kivu**, 79 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 98 sorties (14 guéries). Au total, 364 patients demeuraient hospitalisés dont 261 dans les structures normées. Le taux d'occupation des lits était de **63,0%** ; 21 malades étaient en état critique au CTE de Beni.
- **À la Tshopo**, 3 nouvelles admissions ont été enregistrées. Contre 1 sortie a été rapportée. 14 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de 45,2 %.
- **Au Bas-Uélé**, 16 patients suspects étaient en isolement à la fin de la journée dans les CT de Poko (8), Bondo (5), Limba (ZS de Viadana, 2) et Koteli (1) ; une sortie d'un suspect déclaré non-cas a été enregistrée à Buta.
- **Au Haut-Uélé**, 11 nouvelles admissions ont été enregistrées. Au total, 74 patients sont en isolement dans les CTE ; contre 14 sorties, dont 8 guérisons (1 à Isiro et 7 à Wamba), 5 non-cas et 1 décès confirmé à Paw, soit un taux d'occupation de **53,6 %**.

2.5.2. Défis

- **En Ituri**, capacité d'accueil insuffisante de certains CTE/CT et l'insuffisance de la prise en charge alimentaire demeurent préoccupantes.
- **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.
- **À la Tshopo**, la présence continue de cas confirmés en isolement nécessite le maintien des mesures de prévention et contrôle de l'infection.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, la vaccination des PPL et TPL s'est poursuivie dans les ZS de Buta et d'Aketi et la vaccination compassionnelle a démarré dans la ZS de Viadana (13 vaccinés), portant le cumul provincial à 1 147 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (8,7 %), principalement à Buta (613 ; 21,4 %) et à Ganga (273 ; 20,5 %).
- **En Ituri**, la vaccination des PPL et l'étude sur l'immunité croisée Ervebo/Bundibugyo ont été évaluées avec l'appui de MSF.

2.6.2. Défis

En Ituri, la cible des PPL/TPL reste à redéfinir, ce qui empêche le calcul d'un taux de couverture fiable.

Au Bas-Uélé, mise en marche des UCC non effective, pas de disponibilité du micro-plan validé et des fonds de la vaccination.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, les capacités des membres des ECZ, des IT, des ITA et des agents de santé communautaires ont été renforcées sur la surveillance à base communautaire et la prise en charge aux SSC dans les ZS de Nizi, Mongbwalu, Nyankunde et Rwampara, et les outils de ventilation du budget des ZS ont été analysés en vue du projet de gratuité des soins.
- **Au Bas-Uélé**, la ZS de Ganga/Dingila a été évaluée sur le dépistage du VIH et la mise sous ARV des nouveaux cas, en comparant les périodes de mai à août 2025 et 2026.
- **À la Tshopo**, l'évaluation du CS Wandungu (ZS de Kabondo) a relevé 9 agents vaccinés sur 11 (81,8 %), 8 femmes enceintes absentes sur 25 attendues en CPN (32,0 %), l'absence de zone de triage et une mauvaise gestion des déchets ; le plan de redressement du CS Zawadi a été élaboré.
- **Au Haut-Uélé**, l'évaluation des CS Tuluba (ZS d'Isiro) et maman Kayenga (ZS de Wamba) a montré une forte baisse des consultations curatives (35 en août contre 84 en janvier), des CPN (77 contre 131) et des accouchements (30 contre 55) ; les HGR de Boma Mangbetu, Pawa et Wamba ont reçu des kits PCI de l'UNICEF.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 29 770 visites à domicile ont touché 106 322 personnes ; 1 278 causeries éducatives ont réuni 17 109 personnes, 2 débats communautaires 191 personnes et 83 sensibilisations de masse 3 291 personnes. Au total, 389 alertes communautaires, dont 106 décès, ont été notifiées ; 244 feedbacks sur 256 (95,3 %) ont été résolus dans les 48 heures et aucun incident n'a été rapporté (complétude de 9 ZS sur 28, soit 32,1 %) ; la CREC a facilité le pré-listage de 394 contacts autour de 12 cas confirmés et 13 EDS sur 13.
- **Au Nord-Kivu**, 11 012 visites à domicile ont touché 35 130 personnes, 156 causeries éducatives 5 328 personnes et 36 séances de communication de masse 6 696 personnes ; 466 alertes communautaires sur 650 attendues (71,7 %) ont été notifiées, et 24 feedbacks sur 30 (80,0 %) ainsi que l'incident enregistré à Katwa (refus de décontamination) ont été résolus dans les 48 heures. Le conseil local de sécurité a validé la construction du CTE de Mabalako à Mangina.
- **À la Tshopo**, 207 visites à domicile ont touché 1 186 personnes, 3 causeries éducatives 224 personnes et 7 sensibilisations de masse 3 958 personnes ; les bourgmestres des 6 communes et les leaders locaux ont été engagés autour du Maire de Kisangani, 13 alertes communautaires ont été notifiées (8 à Bafwasende, 3 à Kabondo et 2 à Tshopo) et les 3 refus identifiés ont été levés.

- **Au Bas-Uélé**, 80 visites à domicile ont touché 770 personnes, 3 causeries éducatives 100 personnes et 2 sensibilisations de masse 570 personnes à Viadana, Titule et Ganga, notamment en milieu scolaire à l'institut Maman Sinovia (ZS de Ganga) ; l'alerte communautaire notifiée à Ganga a été traitée (1/1).
- **Au Haut-Uélé**, 394 visites à domicile ont touché 1 493 personnes, 152 causeries éducatives 634 personnes et 2 sensibilisations de masse 369 personnes, et une émission interactive a été organisée à la radio RTK ; 22 alertes communautaires ont été notifiées dans 5 ZS, et les 3 feedbacks ainsi que l'incident enregistré (refus levé dans l'AS Tely, ZS d'Isiro) ont été résolus dans les 48 heures.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 25 cas confirmés sur 49 (51,0 %) de la veille, 99 confirmés en cours de suivi sur 135 (73,3 %), 37 nouveaux suspects sur 73 (50,7 %) et 93 suspects en cours de suivi sur 144 (64,6 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 256 accompagnants et 103 PPL, suivi 23 guéris sur 27 (85,2 %) en communauté et annoncé 78 résultats, dont 25 positifs ; deux séances de self care ont réuni 75 PPL au CTE de Rwampara.
- **En Ituri**, 34 cas confirmés sur 44 (77,3 %) de la veille, 126 confirmés en cours de suivi sur 133 (94,7 %), 57 nouveaux suspects sur 100 (57,0 %) et 122 suspects en cours de suivi sur 133 (91,7 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 447 accompagnants et 78 PPL et annoncé 56 résultats, dont 34 positifs.
- **À la Tshopo**, les équipes ont apporté un soutien psychologique aux 3 cas confirmés suivis au CTE Météo (100 %), réalisé la psychoéducation de 8 suspects et de 1 276 personnes, dont 1 177 élèves à Lubunga et à Bafwasende, et levé 3 résistances sur 4 ; 5 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes (71,4 %).
- **Au Haut-Uélé**, 3 nouveaux confirmés, 22 confirmés en cours de suivi, 7 nouveaux suspects et 43 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; les équipes ont soutenu 49 accompagnants, 57 PPL et 14 enfants séparés en communauté et annoncé 28 résultats, dont 7 positifs.

2.9.2. Défis

- **En Ituri**, seules 13 ZS affectées sur 28 sont couvertes (46,4 %) et les capacités des psychologues et des APS/TPS doivent être renforcées dans la ZS de Mandima pour assurer les interventions autour des cas.
- **Au Haut-Uélé**, les APS de Wamba et de Boma Mangbetu manquent de motos, les kits nutritionnels pour nourrissons sevrés sont insuffisants à Wamba et à Isiro et la remontée des données reste faible à Boma Mangbetu et à Pawa
- **À la Tshopo**, nécessité de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des moyens de communication et de déplacement du pilier.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, déploiement des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana, inventaire des intrants de la DPS et poursuite de la réhabilitation des bureaux de la DPS (OMS) et de la construction du centre de transit de l'HGR de Buta.
- **À la Tshopo**, affectation des 2 véhicules de location dotés par MOMENTUM, réception de 64 800 seringues (OMS) et distribution de 57 tablettes DHIS2 Tracker aux IT de Makiso-Kisangani, Tshopo et Kabondo ; la construction de l'isolement de Kongakonga, du CTE de Bafwasende et l'extension du CTE Météo se poursuivent.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri**, 49 membres du personnel (27 hommes et 22 femmes) ont été briefés sur la PSEAH et ont signé le code de bonne conduite, dont 30 points focaux de cinq ZS formés à Bunia et 19 prestataires du CTE de Lita ; 300 personnes ont été sensibilisées à Bunia, Rwampara et Komanda et seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement.
- **Au Nord-Kivu**, 38 prestataires (24 hommes et 14 femmes) ont été briefés sur la PSEAH à Beni et 69 personnes sensibilisées ; la Responsable du pilier PSEA de la Coordination nationale y a réuni l'ensemble des intervenants PSEA de la riposte ; 6 ZS sur 34 (17,6 %) connaissent le mécanisme de signalement.
- **Au Haut-Uélé**, 6 PPL de l'HGR d'Isiro ont été briefés sur la PSEAH et 63 personnes, principalement des femmes reçues en CPN au CS Tely et à l'HGR, ont été sensibilisées au cours de 4 séances ; 6 ZS sur 13 (46,2 %) connaissent le mécanisme de signalement,
- **Au Sud-Kivu**, 64 staffs et partenaires d'IMC ont été briefés sur la PSEAH dans les ZS de Miti-Murhesa et de Katana ; 18 ZS sur 34 (52,9 %) connaissent le mécanisme de signalement.

2.12.2. Défis

Au niveau national, seules 2 DPS ont rapporté leurs activités PSEA (57,1 %) et les CBCM restent peu efficaces.

MESSAGES CLÉS

- Une transmission communautaire active et soutenue demeure observée dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Haut-Uélé. Tandis que la province du Sud Ubangi n'a notifié aucun cas confirmé au cours des dernières 24 heures et une accalmie est observée dans la province de la Tshopo par rapport aux 72 dernières heures.
- Des progrès à consolider sont enregistrés dans le domaine des investigations épidémiologiques : toutes ont été investigués (**100 %**) des cas suspects a été investiguée dans les 24 heures suivant leur notification. Toutefois, le taux de suivi des contacts est inférieur par rapport à la veille (**73,1 vs 80,3%**). Cependant, les efforts doivent être fournis afin que ce taux atteigne le seuil requis (95 %).
- Renforcer la surveillance, la prise en charge, la PCI, la logistique et l'engagement communautaire, en privilégiant l'augmentation des capacités des CTE/CT au Nord-Kivu, le transfert rapide des suspects et l'isolement des cas confirmés.
- Renforcer la préparation et la réponse à la MVE-B dans le corridor fluvial et les zones environnantes, notamment au Sud-Ubangi, par la recherche active, le suivi des contacts et la disponibilité des intrants. Poursuivre la surveillance transfrontalière avec le Soudan du Sud.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd